📚 ROTEIRO DE ESTUDOS – FARMACOLOGIA

Tema: ANTIDEPRESSIVOS

🔹 PARTE 1 – BASE NEUROBIOLÓGICA DA DEPRESSÃO (Fundamental)

📌 Antes do fármaco: entenda o alvo

Estude:

- Neurotransmissores envolvidos no humor:
  - Serotonina (5-HT)
  - Noradrenalina (NA)
  - Dopamina (DA)
- Hipótese monoaminérgica da depressão
- Sinapse: recaptação, degradação e receptores pós-sinápticos
- Latência terapêutica dos antidepressivos

✏️ Questões dissertativas:

1. Quais monoaminas estão mais relacionadas à fisiopatologia da depressão?
2. Explique a hipótese monoaminérgica da depressão.
3. Por que os antidepressivos não produzem efeito imediato, mesmo aumentando monoaminas rapidamente?
4. Qual a relação entre regulação de receptores e melhora clínica?

🔹 PARTE 2 – CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS ANTIDEPRESSIVOS

📌 Tenha a visão macro antes dos detalhes

Estude as classes:

- ISRS – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina
- IRSN – Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina
- Tricíclicos
- IMAOs
- Antidepressivos atípicos

✏️ Questões dissertativas:

1. Por que os antidepressivos são classificados pelo mecanismo de ação?
2. Qual classe é considerada primeira linha atualmente e por quê?
3. Quais classes são reservadas para casos específicos ou refratários?
4. Como o perfil de efeitos adversos influencia a escolha do antidepressivo?

🔹 PARTE 3 – ISRS (PRIMEIRA LINHA)

📌 Classe mais cobrada e mais prescrita

Estude:

- Mecanismo: inibição seletiva do SERT
- Principais fármacos:
    - Fluoxetina
    - Sertralina
    - Escitalopram
    - Paroxetina
    - Citalopram

- Indicações além da depressão

✏️ Questões dissertativas:

1. Como os ISRS aumentam a neurotransmissão serotoninérgica?
2. Por que os ISRS são considerados mais seguros que os tricíclicos?
3. Cite indicações clínicas dos ISRS além da depressão.
4. Por que a fluoxetina tem maior risco de interação medicamentosa?

📌 Efeitos adversos dos ISRS

Estude com atenção:

- Disfunção sexual
- Náuseas e diarreia
- Insônia ou sedação
- Síndrome serotoninérgica

✏️ Questões dissertativas:

1. Explique a fisiopatologia da disfunção sexual causada pelos ISRS.
2. O que é a síndrome serotoninérgica e como ela se manifesta clinicamente?
3. Por que os ISRS devem ser iniciados em doses baixas?
4. Por que a retirada abrupta pode causar sintomas de descontinuação?

🔹 PARTE 4 – IRSN (Serotonina + Noradrenalina)

📌 Quando a serotonina sozinha não basta

Estude:

- Mecanismo de ação
- Principais fármacos:
    - Venlafaxina
    - Desvenlafaxina
    - Duloxetina
- Indicações específicas

✏️ Questões dissertativas:

1. Qual a vantagem teórica dos IRSN em relação aos ISRS?
2. Em quais pacientes os IRSN são preferidos?
3. Por que os IRSN podem aumentar a pressão arterial?
4. Cite uma indicação clínica não psiquiátrica dos IRSN.

🔹 PARTE 5 – ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS

📌 Muito eficazes, pouco tolerados

Estude:

- Mecanismo: inibição da recaptação de NA e 5-HT
- Bloqueio de receptores:
    - Muscarínicos
    - Histamínicos
    - Alfa-1
- Exemplos:
    - Amitriptilina

    - Nortriptilina
    - Imipramina

✏️ Questões dissertativas:

1. Por que os tricíclicos têm tantos efeitos adversos?
2. Explique os efeitos anticolinérgicos dos tricíclicos.
3. Por que são perigosos em overdose?
4. Em quais situações clínicas os tricíclicos ainda são utilizados?

🔹 PARTE 6 – IMAOs

📌 Pouco usados, muito cobrados teoricamente

Estude:

- Mecanismo: inibição da monoaminoxidase
- Tiramina e efeito “queijo”
- Exemplos:
    - Fenelzina
    - Tranilcipromina

✏️ Questões dissertativas:

1. Qual a função da monoaminoxidase no SNC?
2. Explique a crise hipertensiva associada aos IMAOs.
3. Por que os IMAOs exigem restrição alimentar?
4. Em quais casos os IMAOs ainda podem ser indicados?

🔹 PARTE 7 – ANTIDEPRESSIVOS ATÍPICOS

📌 Mecanismos diversos

Estude:

- Bupropiona
- Mirtazapina
- Trazodona

✏️ Questões dissertativas:

1. Qual o diferencial farmacológico da bupropiona?
2. Por que a mirtazapina aumenta o apetite e causa sedação?
3. Em qual perfil de paciente a trazodona é útil?
4. Cite vantagens clínicas dos antidepressivos atípicos.

🔹 PARTE 8 – PRINCÍPIOS CLÍNICOS IMPORTANTES

📌 Sempre cai em prova

Estude:

- Tempo para resposta terapêutica
- Duração do tratamento
- Troca de antidepressivos
- Risco de suicídio no início do tratamento

✏️ Questões dissertativas:

1. Quanto tempo leva para avaliar resposta ao antidepressivo?
2. Por quanto tempo o tratamento deve ser mantido após melhora?

3. Por que há aumento do risco de suicídio no início do tratamento?

4. Quais cuidados devem ser tomados ao trocar antidepressivos?

🔹 PARTE 9 – FECHAMENTO PRÉ-AULA (20 min)

✔️ Faça um **quadro comparativo** entre ISRS, IRSN e tricíclicos
✔️ Liste **3 situações clínicas → 1 antidepressivo preferido**
✔️ Responda por escrito:

> "Por que nem todo paciente deprimido melhora com o mesmo antidepressivo?"

📘 ROTEIRO RESOLVIDO – ANTIDEPRESSIVOS

🔹 PARTE 1 – FUNDAMENTOS NEUROQUÍMICOS (BASE DO CAPÍTULO)

🔴 CENTRAL

1. Quais neurotransmissores estão envolvidos nos transtornos depressivos segundo a Whalen?

Segundo a Whalen, os transtornos depressivos estão associados principalmente a **alterações na neurotransmissão monoaminérgica**, envolvendo:

- **Serotonina (5-HT)**
- **Noradrenalina (NA)**
- **Dopamina (DA)** (papel secundário, mas relevante)

Essas monoaminas estão envolvidas na regulação do humor, sono, apetite, motivação e resposta ao estresse.

⚠️ **A Whalen enfatiza que** a depressão **não é apenas "falta de serotonina"**, mas um distúrbio funcional de circuitos neuronais modulados por monoaminas.

🔴 **CENTRAL**

2. Explique a hipótese monoaminérgica da depressão conforme apresentada no livro.

A hipótese monoaminérgica propõe que a depressão resulta de uma **deficiência funcional das monoaminas** no SNC, especialmente serotonina e noradrenalina, em áreas como o córtex pré-frontal e sistema límbico.

Os antidepressivos **aumentam a disponibilidade sináptica dessas monoaminas**, seja por:

- inibição da recaptação,
- ou inibição da degradação enzimática.

⚠️ **A Whalen deixa claro** que essa hipótese explica o **mecanismo de ação dos fármacos**, mas **não explica completamente a etiologia da depressão**.

🔴 **CENTRAL**

3. Por que existe latência terapêutica dos antidepressivos?

Apesar do aumento imediato das monoaminas, o efeito clínico leva **2 a 6 semanas** porque depende de:

- dessensibilização de **autorreceptores pré-sinápticos inibitórios**,
- alterações na expressão gênica,
- reorganização da neurotransmissão pós-sináptica.

⚠️ **Isso cai muito em prova**:

> *"O efeito antidepressivo não depende apenas do aumento agudo de neurotransmissores."*

🔹 PARTE 2 – CLASSIFICAÇÃO DOS ANTIDEPRESSIVOS (ESTRUTURA DA WHALEN)

🔴 **CENTRAL**

4. Como a Whalen classifica os antidepressivos?

A Whalen classifica os antidepressivos **pelo mecanismo de ação**:

1. **ISRS** – Inibidores seletivos da recaptação de serotonina

2. **IRSN** – Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina
3. **Antidepressivos tricíclicos**
4. **IMAOs** – Inibidores da monoaminoxidase
5. **Antidepressivos atípicos**

⚠️ **Atenção:** provas costumam cobrar **mecanismo + exemplo**.

🔴 **CENTRAL**

5. Qual é a classe de primeira linha segundo a Whalen e por quê?

Os **ISRS** são considerados **primeira linha**, pois:

- eficácia semelhante às classes mais antigas,
- melhor perfil de segurança,
- menor toxicidade em overdose,
- menos efeitos anticolinérgicos e cardiovasculares.

⚠️ **A Whalen enfatiza** que a escolha do antidepressivo envolve **eficácia + tolerabilidade**, não apenas potência.

🔹 PARTE 3 – ISRS (MAIS COBRADOS)

🔴 **CENTRAL**

6. Descreva o mecanismo de ação dos ISRS segundo a Whalen.

Os ISRS inibem seletivamente o **transportador de serotonina (SERT)** na membrana pré-sináptica, reduzindo a recaptação de serotonina e aumentando sua concentração na fenda sináptica.

Isso resulta em maior ativação dos receptores serotoninérgicos pós-sinápticos.

🔴 **CENTRAL**

7. Cite os principais ISRS destacados pela Whalen.

- Fluoxetina
- Sertralina
- Paroxetina
- Citalopram
- Escitalopram

- Fluvoxamina

⚠️ **Cai em prova**: reconhecer o grupo pelo nome do fármaco.

🔴 **CENTRAL**

8. Quais são os efeitos adversos típicos dos ISRS?

- Distúrbios gastrointestinais (náusea, diarreia)
- Insônia ou sedação
- **Disfunção sexual** (muito enfatizada pela Whalen)
- Ansiedade inicial
- Síndrome serotoninérgica (em interações)

⚠️ **A Whalen destaca** que a disfunção sexual é **causa frequente de abandono do tratamento**.

🔴 **CENTRAL**

9. Explique a síndrome serotoninérgica conforme a Whalen.

A síndrome serotoninérgica é causada por **excesso de serotonina**, geralmente por associação de fármacos serotoninérgicos.

Tríade clássica:

- Alterações mentais (agitação, confusão)
- Instabilidade autonômica (febre, sudorese)
- Alterações neuromusculares (tremor, hiperreflexia)

⚠️ **Isso é clássico de prova teórica.**

🔹 PARTE 4 – IRSN

🔴 **CENTRAL**

10. Qual o mecanismo de ação dos IRSN?

Os IRSN inibem a recaptação de:

- serotonina **e**
- noradrenalina

Isso amplia o efeito antidepressivo, especialmente em quadros mais graves.

🔴 **CENTRAL**

11. Cite os principais IRSN segundo a Whalen.

- Venlafaxina
- Desvenlafaxina
- Duloxetina

🟡 **COMPLEMENTAR:** uso em dor neuropática e fibromialgia.

🔴 **CENTRAL**

12. Qual efeito adverso importante dos IRSN a Whalen destaca?

- **Aumento da pressão arterial**, especialmente com venlafaxina em doses altas.

⚠️ **Cai em prova**: relação noradrenalina ↔ PA.

🔹 PARTE 5 – ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS

🔴 **CENTRAL**

13. Explique o mecanismo de ação dos tricíclicos.

Inibem a recaptação de serotonina e noradrenalina, mas **não seletivamente**, bloqueando também:

- receptores muscarínicos,
- receptores H1,
- receptores alfa-1.

🔴 **CENTRAL**

14. Principais efeitos adversos dos tricíclicos.

- Anticolinérgicos: boca seca, retenção urinária
- Sedação
- Hipotensão ortostática

- **Cardiotoxicidade**

⚠️ **A Whalen enfatiza fortemente** a toxicidade cardíaca.

🔴 **CENTRAL**

15. Por que os tricíclicos são perigosos em overdose?

Porque bloqueiam canais de sódio cardíacos →
arritmias ventriculares potencialmente fatais.

⚠️ **Isso cai MUITO em prova.**

🔹 PARTE 6 – IMAOs

🔴 **CENTRAL**

16. Qual o mecanismo de ação dos IMAOs?

Inibem a monoaminoxidase (MAO), enzima que degrada:

- serotonina
- noradrenalina
- dopamina

🔴 **CENTRAL**

17. Explique o “efeito tiramina” (efeito queijo).

A tiramina não degradada promove liberação excessiva de noradrenalina →
crise hipertensiva grave.

⚠️ **Clássico de prova.**

🔹 PARTE 7 – ANTIDEPRESSIVOS ATÍPICOS

🔴 **CENTRAL**

18. Qual o diferencial da bupropiona segundo a Whalen?

- Inibe recaptação de noradrenalina e dopamina
- Não causa disfunção sexual
- Útil em cessação do tabagismo

🔴 **CENTRAL**

19. Por que a mirtazapina causa sedação e ganho de peso?

Bloqueio de receptores histamínicos H1 e modulação serotoninérgica.

🔹 PARTE 8 – PRINCÍPIOS CLÍNICOS (SEMPR E COBRADOS)

🔴 **CENTRAL**

20. Por quanto tempo manter o tratamento antidepressivo?

- **Mínimo: 6–12 meses após remissão** do primeiro episódio.

🔴 **CENTRAL**

21. Por que há risco aumentado de suicídio no início do tratamento?

Porque a melhora da energia ocorre antes da melhora do humor.

⚠️ **A Whalen enfatiza acompanhamento rigoroso no início.**

🧠 RESUMO FINAL – O QUE MAIS CAI EM PROVA (WHALEN)

✔️ ISRS = primeira linha
✔️ Latência terapêutica
✔️ Disfunção sexual (ISRS)
✔️ Cardiotoxicidade (tricíclicos)
✔️ Tiramina + IMAO = crise hipertensiva